

## ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNOS PSICÓTICOS

*Antonio Serrano Garcia*

### INTRODUCCIÓN

La esquizofrenia es una enfermedad del Sistema Nervioso que se engloba en el grupo más amplio de los Trastornos Psicóticos, que se caracterizan por una pérdida de contacto con la realidad.

En los Servicios de Urgencias el objetivo principal consiste en identificar la presencia de este grupo de trastornos y solicitar la valoración de un especialista en Psiquiatría. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los pacientes con este grupo de trastornos presentan una elevada prevalencia de alteraciones endocrino-metabólicas y que la presencia de un trastorno psicótico no excluye la presencia de patología somática, siendo frecuente la existencia de psicosis secundarias.

### DIAGNÓSTICO

El primer paso de cara al manejo de este grupo de pacientes en los Servicios de Urgencias consiste en asegurar su permanencia en el Hospital hasta que su evaluación haya sido completada, ya que la conciencia de enfermedad suele ser deficitaria y frecuentemente acuden a Urgencias por otros motivos. Puede ser necesario que el paciente sea supervisado de forma continua hasta que se complete su evaluación. No es conveniente hacer creer a los pacientes que se investiga un cuadro somático cuando se sospecha una alteración psiquiátrica puesto que, si bien puede facilitar el manejo inicialmente, disminuirá la posibilidad de que el paciente vuelva a solicitar ayuda para su proceso si se siente engañado y eso causará un innegable quebranto en el paciente.

Los criterios diagnósticos de la esquizofrenia se encuentran recogidos en la CIE-10. Ante la presencia en la anamnesis de alucinaciones o ideas delirantes debe realizarse una cuidadosa exploración de la conciencia, la orientación, el curso del pensamiento y la esfera instinto-vegetativa, así como una amplia revisión de los antecedentes físicos y psíquicos del paciente.

En caso de que no existan antecedentes de cuadros psicóticos en el paciente o exista un cambio importante en la evolución de un cuadro de psicosis conocido previo, debe descartarse la presencia de una psicosis secundaria por lo que se recomienda la realización de las siguientes determinaciones:

- Tensión Arterial
- Temperatura
- Frecuencia cardiaca
- Tóxicos en orina
- Alcoholemia
- Hemograma
- Bioquímica
- Sistemático de orina
- TAC craneal (en mayores de 40 años)

Algunas causas de psicosis secundarias, sin pretender ser exhaustivos, podemos encontrarlas en:

- Consumo y/o abstinencia de alcohol y/o drogas

- Enfermedades neurológicas, como el Parkinson (ocasionalmente como efecto secundario de fármacos dopaminérgicos) y la Corea de Huntington
- Tumores o quistes cerebrales
- Demencias
- VIH y otras infecciones que afecten el cerebro
- Como efecto secundario de algunos fármacos como esteroides y estimulantes
- Algunos tipos de epilepsia
- Accidente cerebrovascular
- Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico
- Alteraciones hormonales
- Postparto
- Enfermedades autoinmunes que afecten al SNC

Una vez descartada la psicosis secundaria es preciso solicitar consulta al especialista en Psiquiatría que decidirá el abordaje más indicado.

### TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Las psicosis primarias deben ser abordadas por un especialista, puesto que el abordaje farmacológico de forma aislada suele ser insuficiente para el control del cuadro y es preciso planificar los cuidados a largo plazo.

En caso de psicosis secundarias puede requerirse la intervención de diferentes especialistas, recomendándose que la hospitalización, si fuese necesaria, se realice en un Servicio Médico con el apoyo del Servicio de Psiquiatría de Enlace del centro.

En caso de que aparezca un cuadro de agitación psicomotriz en el contexto de un episodio psicótico se recomienda consultar el capítulo específico sobre este tema en esta misma obra.

### IMPORTANTE

- Ante la presencia de síntomas psicóticos es imprescindible descartar un origen somático de los mismos

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Freudenreich O, Brown HE, Holt DJ. Psychosis and schizophrenia. In: Stern TA, Fava M, Wilens TE, Rosenbaum JF, eds. Massachusetts General Hospital Comprehensive Clinical Psychiatry. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016:chap 28.
- 2.- OMS (1992), CIE-10. Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripción clínicas y pautas para el diagnóstico, Madrid. Ed. Méditor.